SEMINAR SEKOLAH PASCASARJANA IPB
PROGRAM STUDI ILMU GIZI · SENIN, 2 NOVEMBER 2026

Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin

Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial

Marhamah[1], Hardinsyah[2], Cesilia Meti Dwiriani[2], Lilik Kustiyah[2], Irman Hermadi[3]

[1]Program Doktor Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [2]Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB • [3]Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

Program Studi Ilmu Gizi, FKGiz IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor
0813-8172-4884
am_marhamah@apps.ipb.ac.id

SHINING
Sehat Sebelum Hamil itu Penting
Edukasi gizi prakonsepsi online 8 minggu berbasis *Health Belief Model* (HBM)

1 Abstrak

Latar belakang — Bukti penggunaan media sosial (medsos) calon pengantin (catin) dan kinerja edukasi gizi prakonsepsi online di Indonesia masih terbatas.

Tujuan — Mengevaluasi implementasi platform web SHINING kelompok kontrol serta menganalisis penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT.

Metode — *Cross-sectional* dan evaluasi proses; data awal catin Kota Binjai (Juli–Oktober 2026): 198 pendaftar, 74 dengan data lengkap.

Hasil — Hanya 38,9% menyelesaikan keenam instrumen; penurunan terbesar sebelum tes pengetahuan 48 butir. Kiriman ganda 13,8%; blok makanan pokok hilang pada 26,9% FFQ. WhatsApp dominan (59,5%). Pengetahuan baik 59,5% dan berkorelasi dengan sikap (r=0,414), namun 51,4% berat badan lebih/obesitas. IMT lebih rendah berhubungan dengan durasi medsos lebih lama (r=−0,331) dan sumber akun tenaga kesehatan; memeriksa kebenaran informasi berhubungan dengan sikap lebih positif (r=0,287).

Simpulan — Edukasi online perlu mengarahkan catin ke sumber kredibel dan membiasakan verifikasi informasi; platform perlu instrumen ringkas, konfirmasi penyimpanan di server, dan uji coba pada kelompok sasaran.

Kata kunci: calon pengantin, edukasi online, evaluasi proses, gizi prakonsepsi, media sosial

2 Pendahuluan

Latar belakang



±50%
orang dewasa Indonesia berat badan lebih/obesitas

72,78%
penduduk mengakses internet; 77,57% untuk medsos

44–77%
catin di Bogor & Jakarta Barat berpengetahuan gizi kurang

±50%
unggahan gizi akun populer tidak akurat

Masalah utama

- Masa prakonsepsi periode kritis memperbaiki gizi & kesehatan catin sebagai calon ayah dan ibu, tetapi sering diabaikan.
- Dewasa muda mencari info kesehatan di medsos, padahal misinformasi gizi luas; dalam HBM, medsos = *isyarat bertindak*, bergantung pada informasi yang dibaca dan cara menilainya.
- Edukasi online catin hasilnya beragam; intervensi prakonsepsi berbasis HP efeknya masih terbatas.
- Angka berhenti tinggi (*law of attrition*), sehingga cara platform dikembangkan, diubah, dan digunakan perlu dilaporkan.
- Di negara berpenghasilan rendah–menengah, laporan masih terbatas; HP spesifikasi rendah, HP bersama, dan jaringan tidak stabil jadi hambatan tersering.

Tujuan penelitian

(1) Mengevaluasi proses implementasi platform web media edukasi SHINING, meliputi penyelesaian pengisian dan mutu data; **(2)** menganalisis pola penggunaan medsos catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT, sebagai dasar pengembangan edukasi gizi prakonsepsi online yang mudah digunakan.

3 Metode

Desain	*Cross-sectional* + evaluasi proses, bagian dari riset pengembangan SHINING (model ADDIE)
Subjek	Catin 20–40 tahun, kelompok kontrol; rekrutmen via brosur kode QR & WhatsApp; **198** memenuhi syarat, **74** dianalisis (30 laki-laki, 44 perempuan)
Instrumen	Pengetahuan 48 butir (baik >80%); sikap 24 butir, 6 konstruk HBM, Likert 4 poin (positif ≥72); FFQ; IPAQ-SF; kuesioner medsos; IMT dari BB/TB isian sendiri (PNPK 2025)
Analisis	Spearman, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, khi-kuadrat/eksak Fisher; hubungan bermakna diuji ulang dengan kontrol peran; p<0,05; Python & SPSS
Waktu & lokasi	Pembinaan catin Kota Binjai, Sumatera Utara; Juli–Oktober 2026
Etik	KEPK Poltekkes Kemenkes Medan No. 01.26.1986/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2025; persetujuan elektronik
Indikator proses	Penyelesaian & lama pengisian (*timestamp*), kiriman ganda, karantina, data hilang; kemudahan dinilai 15 mahasiswa (skala 1–5)

Fokus makalah
Proses implementasi (Tujuan 1) & pola medsos (Tujuan 2) pada data awal kelompok kontrol; evaluasi dampak dilaporkan terpisah.

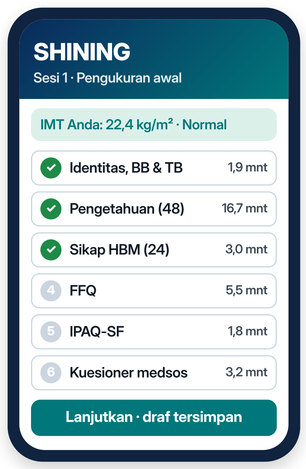
4 Alur Penelitian (Model ADDIE)

FOKUS MAKALAH INI

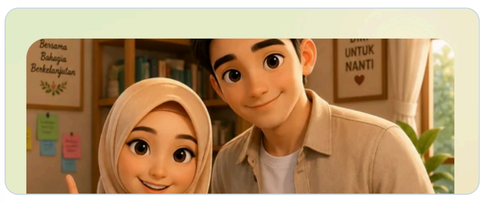
1. **Analysis** (Analisis kebutuhan) — Kajian literatur, survei awal, analisis kebutuhan
2. **Design** (Desain media) — Desain konten berbasis *Health Belief Model* (HBM)
3. **Development** (Pengembangan) — Pengembangan platform SHINING dan materi edukasi
4. **Implementation** (Implementasi) — Uji coba, rekrutmen peserta, implementasi edukasi online
5. **Evaluation** (Evaluasi) — Analisis proses, pola penggunaan media, dan evaluasi dampak

5.1 Hasil · Platform SHINING

Tujuan 1



Gambar 2. Alur sesi 1 (median waktu pengisian)



SHINING
Sehat Sebelum Hamil itu Penting · mulai.edukasi-catin.id

- **Web satu halaman, ramah HP:** tanpa unduh aplikasi dan tanpa akun.
- **Masuk dengan nama + nomor HP/WA**, cek kelayakan (catin 20–40 tahun) dan persetujuan.
- **Enam instrumen sesi 1:** identitas (BB & TB), pengetahuan, sikap HBM, FFQ, IPAQ-SF, kuesioner medsos; umpan balik IMT & status gizi.
- **Tersimpan otomatis ke Google Sheets**; kiriman berulang ditandai, data tak dikenali masuk **lembar karantina**.
- **Penilaian awal (15 mahasiswa):** rerata 4,40–4,73 dari 5; terendah pada pengisian kuesioner.

5.2 Hasil · Pengembangan Iteratif Platform

Tujuan 1



Siklus pengembangan iteratif

13,8%
kiriman berulang (186 dari 1.344 rekaman)

22/23
rekaman karantina di minggu pertama

26,9%→0%
FFQ tanpa makanan pokok setelah simpan draf (p=0,04)

Akhir Juli	MASALAH: Persetujuan tidak tersimpan; angka nol nomor HP hilang; status "selesai" hanya di HP	PERBAIKAN: Skrip ditulis ulang (normalisasi nomor, karantina, penanda duplikat); status dikonfirmasi server
Agustus	PENILAIAN AWAL: Kemudahan dan keterbacaan dinilai oleh 15 mahasiswa	CATATAN: Tidak ada masalah besar yang dilaporkan
Awal Oktober	MASALAH: Progres hilang saat berganti telepon; isian kosong	PERBAIKAN: Progres per nomor telepon; validasi isian; kirim ulang otomatis
Pertengahan Oktober	MASALAH: Blok makanan pokok FFQ hilang; halaman awal terlalu banyak tahap	PERBAIKAN: Simpan draf otomatis; blok makanan pokok wajib; persetujuan berlapis
Akhir Oktober	STATUS: Pendaftaran kelompok kontrol ditutup	TINDAK LANJUT: Data dikunci untuk analisis

5.3 Penyelesaian Instrumen Sesi 1

Tujuan 1 · n = 198

TAHAP	DIKIRIM, N (%)	VALID	MEDIAN (RAK), MNT
Persetujuan	171 (86,4%)	–	–
Formulir identitas	161 (81,3%)	160	1,9 (1,1–2,9)
Tes pengetahuan (48 butir)	107 (54,0%)	106	16,7 (10,7–34,4)
Skala sikap (24 butir)	96 (48,5%)	94	3,0 (1,6–4,7)
FFQ	92 (46,5%)	88	5,5 (4,0–7,8)
Kuesioner medsos	82 (41,4%)	80	3,2 (2,1–4,1)
IPAQ-SF	82 (41,4%)	67	1,8 (1,2–2,7)
Keenam instrumen	77 (38,9%)	59	–

Penurunan terbesar (81,3% → 54,0%) **sebelum tes pengetahuan**, instrumen terpanjang (Galesic & Bosnjak 2009). Setelah perbaikan, penyelesaian naik **37,2% → 55,6%** (p=0,137).

45,5%
dari 77 yang tuntas selesai ≤1 jam

70,1%
selesai ≤24 jam

3/22
(14%) membuka lembar informasi persetujuan lengkap (median 11 detik)

Kiriman ganda: dipakai yang paling lengkap. Valid: BB/TB wajar & butir terisi sesuai batas minimal. RAK: rentang antarkuartil.

5.4 Penggunaan Media Sosial

Tujuan 2 · n = 74

INDIKATOR	%
Platform utama: WhatsApp	59,5
Platform utama: TikTok/Instagram	33,8
Akses hampir terus-menerus (±setiap jam)	73,0
Durasi ≥3 jam/hari	51,4
Pernah mencari info prakonsepsi[a]	87,7
Selalu memeriksa kebenaran info[a]	61,6
Sumber: akun nakes/lembaga resmi[b]	75,7
Sumber: influencer[b]	39,2
Pernah tertarik produk yang dipromosikan	71,6

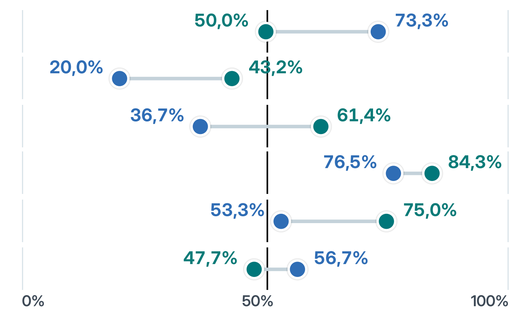
WhatsApp efektif sebagai pengingat kesehatan (Laurence et al. 2025); ketertarikan pada produk promosi perlu diwaspadai (Agustiani et al. 2026).

Hubungan (n=74): pengetahuan–sikap r=0,414 (p<0,001); durasi medsos–IMT r=−0,331 (p=0,004); memeriksa kebenaran info–sikap r=0,287 (p=0,014); IMT lebih rendah bila sumber info akun nakes (22,5 vs 26,6 kg/m²; p=0,022).

Subjek: 59,5% perempuan; 60,6% ≤SMA. [a]n=73. [b]Boleh lebih dari satu sumber.

5.5 Menurut Peran Catin

Tujuan 2



Catin laki-laki lebih tua dan seluruhnya bekerja; pengetahuan & sikap cenderung lebih rendah (sejalan Zahra et al. 2024), tetapi tidak lebih mudah berhenti (selesai 47,0% vs 47,9%; p=0,910).

*p<0,05 (khi-kuadrat/eksak Fisher; Mann-Whitney untuk skor).

6 Simpulan, Saran & Implikasi

SIMPULAN

- Platform web sederhana dapat dipakai, namun **beban peserta, kiriman ganda, dan kehilangan data tak terlihat** perlu diantisipasi sejak perancangan.
- Penggunaan medsos catin **intensif dan didominasi WhatsApp**.
- Pengetahuan umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap HBM, tetapi **>50% catin berat badan lebih/obesitas**.
- IMT lebih rendah & sikap lebih positif berhubungan dengan **sumber kredibel dan memeriksa kebenaran informasi**, bukan frekuensi akses.

SARAN

- Gunakan **instrumen ringkas** dan pantau data secara rutin.
- Biasakan catin **memeriksa kebenaran informasi & izin edar produk**, dan gunakan referensi kredibel.
- Manfaatkan **WhatsApp** untuk pengingat dan pendampingan.

IMPLIKASI

- **Tes panjang dipecah** ke beberapa kunjungan + simpan-lanjut.
- **Pengingat terjadwal** via WhatsApp menekan angka berhenti.
- **Kiriman ganda & HP bersama** ditangani dengan penanda peserta dan aturan baku.
- **Penyimpanan dikonfirmasi server**; data dipantau tiap minggu.
- **Pesan sesuai peran:** laki-laki via WhatsApp; perempuan juga via TikTok/Instagram.
- **Perubahan didokumentasikan** bertanggal; kelompok kontrol–intervensi dipisah.

Keterbatasan: sampel kecil, BB/TB isian sendiri, eksploratif tanpa regresi, potong lintang; alasan berhenti tidak terekam.

7 Ucapan Terima Kasih

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
- Calon Pengantin Kota Binjai
- Seluruh pihak yang berkontribusi

Akses SHINING
mulai.edukasi-catin.id
1. Pindai QR atau buka tautan
2. Isi nama dan nomor WhatsApp
3. Baca persetujuan, lalu mulai

Pustaka utama. Amiri P et al. 2023. BMC Health Serv Res 23:1176 · Atmaka DR et al. 2022. Media Gizi Indones 17(1SP):1–5 · BPS 2025 · Chen X et al. 2018. J Health Commun 23(8):724–734 · Denniss E et al. 2024. IJBNPA 21:16 · Eysenbach G. 2005. JMIR 7(1):e11 · Eysenbach G. 2011. JMIR 13(4):e126 · Faverio M, Sidoti O. 2024. Pew Research Center · Galesic M, Bosnjak M. 2009. Public Opin Q 73(2):349–360 · Janz NK, Becker MH. 1984. Health Educ Q 11(1):1–47 · Lam BT et al. 2025. JMIR 27:e67640 · Laurence MC et al. 2025. Front Digit Health 7:1542006 · Lim MSC et al. 2022. JMIR 24(1):e23656 · Meyerowitz-Katz G et al. 2020. JMIR 22(9):e20283 · Musgrave L et al. 2023. JMIR 25:e41900 · Stephenson J et al. 2018. Lancet 391:1830–1841 · Zahra SS et al. 2024. HPCEJ 3(1)